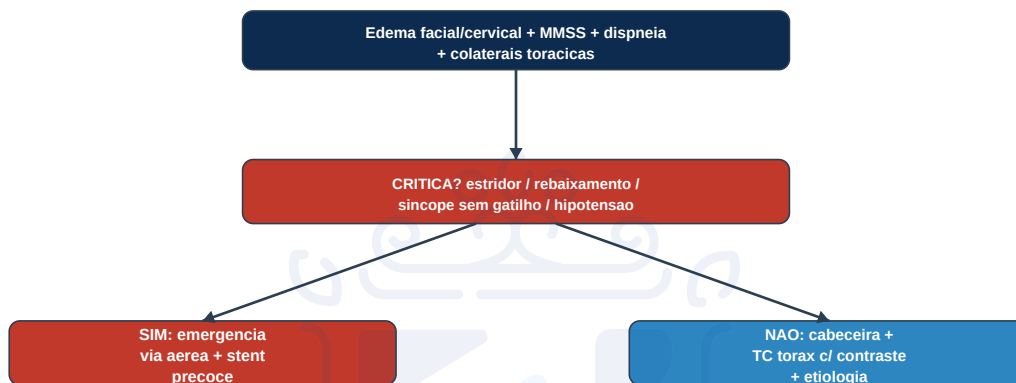


SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR (SVCS)

FLUXOGRAMA — CONGESTÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

SVCS — IDENTIFICAR A FORMA CRÍTICA



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Sinais/sintomas por obstrução (parcial ou completa) do fluxo na veia cava superior
- Gera congestão venosa de cabeça, pescoço e MMSS
- Edema facial/cervical, edema de MMSS, dispneia, tosse, colaterais torácicas dilatadas
- Sintomas pioram ao DEITAR/abaixar a cabeça

ETIOLOGIAS

Grupo	Causas	Pista temporal
Malignas (maioria)	Compressão/invasão mediastinal: câncer de pulmão, linfomas	Semanas (massa/compressão)
Benignas (crescentes)	Trombose/estenose por cateter central, hemodiálise, portocath, marcapasso/CDI	Horas-dias (trombose)

RED FLAGS — SVCS CRÍTICA (via aérea / SNC)

TRATAR COMO EMERGÊNCIA

- Edema laríngeo: ESTRIDOR, voz abafada/rouquidão progressiva, piora rápida da dispneia
- Edema cerebral: confusão/obnubilação, cefaleia intensa, alterações visuais, síncope
- Compromisso hemodinâmico: síncope sem gatilho, hipotensão
- Regra prática: estridor + rebaixamento + síncope 'do nada' + hipotensão = SVCS crítica
- Acionar intervenção (radiologia intervencionista/vascular) precocemente: stent é o alívio mais rápido (~0-72h)

AVALIAÇÃO E EXAMES

INVESTIGAÇÃO

- Exame: sinais vitais, SpO2, nível de consciência; face/pescoço (edema, plethora, turgência jugular)
- Tórax: colaterais dilatadas; via aérea (estridor/edema de língua); MMSS (edema/dor assimétrica = trombose)
- TC de TÓRAX COM CONTRASTE (principal exame): local, gravidade e etiologia
- USG Doppler (jugular/subclávia/inominada) se suspeita de trombose por cateter/dispositivo
- Venografia = padrão-ouro no contexto de intervenção endovascular (stent/trombólise)
- Labs: hemograma, função renal (contraste/anticoag), coagulograma, gaso se insuf. respiratória

TRATAMENTO NO PS — MEDIDAS IMEDIATAS

Rx PASSOS GERAIS

Cabeceira elevada 30-45 graus (reduz a pressão venosa em cabeça/pescoço — medida simples e eficaz)
Oxigênio se hipóxia + monitorização contínua
EVITAR punção/infusão em MMSS (pressão venosa alta piora edema/fluxo) -> preferir acesso em MMII / veia femoral
Analgesia/ansiolítico com CAUTELA
Se crítica (estridor/rebaixamento/hipotensão): suporte de via aérea + acionar intervenção para stent precoce

TRATAMENTO ESPECÍFICO POR ETIOLOGIA

Etiologia	Conduta
Trombose (cateter/dispositivo)	Anticoagulação sistêmica; ± trombólise/trombectomia antes do stent em trombo agudo; considerar retirar o cateter
Compressão tumoral	Planejar com oncologia/radio: QT (pulmão pequenas células/linfoma) ou RT; stent para alívio rápido nos casos severos
Adjuvantes	Corticoide/diurético usados em alguns cenários (evidência limitada; dexametasona se linfoma provável ou edema de VA)

ARMADILHA — DIAGNÓSTICO TECIDUAL

NÃO IRRADIAR ÀS CEGAS

- Evitar radioterapia ANTES do diagnóstico tecidual quando possível (pode inviabilizar a biópsia e não dá alívio imediato)
- Em casos severos, o stent dá alívio rápido e permite tratar o tumor depois com diagnóstico definido
- RT é mais lenta (melhora em dias-semanas); QT é melhor em tumores quimiossensíveis
- Acesso venoso em MMII evita agravar a congestão e a imprevisibilidade do fluxo

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: sinais de gravidade (estridor, rebaixamento, síncope, hipotensão), necessidade de O₂, trombose extensa, suspeita forte de malignidade sintomática
- ☐ UTI: SVCS crítica, via aérea ameaçada, choque, rebaixamento
- ☐ ALTA só se TODOS: quadro leve/estável, saturando bem, etiologia provável definida e plano em curto prazo
- ☐ Alarme: piora rápida da dispneia, estridor/rouquidão, confusão, síncope, cefaleia intensa, piora ao deitar, edema assimétrico de braço
- ☐ Iniciar anticoagulação se trombose confirmada/altamente provável

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- SVCS (gravidade: leve/moderada/crítica). Início: horas-dias (trombose) vs semanas (massa).
- Neoplasia conhecida (pulmão/linfoma): sim/não. Cateter/port/hemodiálise/marcapasso: sim/não.
- Sinais de gravidade: estridor/rebaixamento/síncope/hipotensão. TC tórax c/ contraste: ____.
- Condutas: cabeça elevada, O₂, acesso em MMII, anticoagulação (se trombose), ± corticoide. Solicito intervenção endovascular (stent) / UTI / investigação oncológica rápida.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com SVCS apresenta estridor, rouquidão progressiva, confusão e síncope sem gatilho. Como classificar e conduzir?

- A) Quadro leve — alta com orientações
- B) SVCS crítica — emergência: suporte de via aérea e acionar intervenção para stent precoce
- C) Conjuntivite — colírio
- D) Crise hipertensiva — anti-hipertensivo
- E) Quadro ansioso — ansiolítico e alta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame de imagem principal para avaliar a SVCS no PS?

- A) Radiografia de tórax
- B) Tomografia de tórax com contraste
- C) Ecocardiograma
- D) Ressonância de crânio
- E) Cintilografia óssea

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual cuidado com acesso venoso é recomendado na SVCS?

- A) Preferir punção em membros superiores
- B) Evitar punção/infusão em MMSS e preferir acesso em MMII (veia femoral)
- C) Usar exclusivamente veia jugular
- D) Não puncionar em nenhum sítio
- E) Acesso intraósseo no úmero

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual a etiologia MAIS comum da síndrome da veia cava superior?

- A) Trombose por cateter
- B) Causas malignas (câncer de pulmão e linfomas)
- C) Trauma cervical
- D) Insuficiência cardíaca
- E) Pericardite

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que se deve evitar radioterapia antes do diagnóstico tecidual na SVCS por provável massa tumoral?

- A) Porque a radioterapia é contraindicada em câncer
- B) Porque pode inviabilizar a biópsia/diagnóstico e não oferece alívio imediato; o stent dá alívio rápido
- C) Porque a radioterapia piora a trombose
- D) Porque sempre causa edema cerebral
- E) Porque não há tratamento para SVCS

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Estridor, rebaixamento e síncope sem gatilho caracterizam SVCS crítica (via aérea/SNC ameaçados): é emergência, com suporte de via aérea e acionamento precoce de intervenção endovascular (stent), o alívio mais rápido.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A TC de tórax com contraste é o principal exame: define localização, gravidade e etiologia da obstrução (massa vs trombo). A venografia é o padrão-ouro apenas no contexto da intervenção endovascular.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na SVCS, evita-se puncionar/infundir em MMSS (a pressão venosa elevada agrava o edema e torna o fluxo imprevisível); prefere-se acesso em MMII (veia femoral).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A maioria das SVCS é de causa maligna, por compressão/invasão mediastinal — sobretudo câncer de pulmão e linfomas. Causas benignas (trombose por cateter/dispositivo) vêm crescendo.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Irradiar antes da biópsia pode inviabilizar o diagnóstico tecidual e não dá alívio imediato. Em casos severos, o stent oferece alívio rápido, permitindo depois o tratamento oncológico com diagnóstico definido.

SM24
Suporte ao Plantão Médico